SDG Ziel 2	Kein Hunger
SDG Unterziel 2.2	Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen
SDG Indikator 2.2.2	Prävalenz von Fehlernährung (Gewicht zur Körpergröße >+2 oder <-2 Standardabweichung vom Median gemäß den Standards der WHO für das Wachstum von Kindern) bei Kindern unter 5 Jahren, nach Art der Fehlernährung (Auszehrung und Übergewicht)
Zeitreihe	Auszehrung und Übergewicht

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe
   - Stand der nationalen Metadaten: 6. Juli 2023
   - Nationale Daten: https://sdg-indikatoren.de/2-2-2
   - Definition: Die Zeitreihe stellt die altersstandardisierte Prävalenz von Fehlernährung bei Kindern im Alter von 3 bis 4 Jahren dar. Grundlage ist der Bevölkerungsstand vom 31. Dezember 2015.

     Auszehrung ist definiert als ein Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße, das mehr als zwei Standardabweichungen unter dem Median der Wachstumsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder liegt.

     Übergewicht ist definiert als ein Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße, das mehr als zwei Standardabweichungen über dem Median der WHO-Wachstumsstandards für Kinder liegt.
   - Disaggregation: Art der Fehlernährung, Geschlecht

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten
   - Stand der UN-Metadaten: März 2025
   - UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-02a.pdf
   - Die Zeitreihe entspricht teilweise den UN-Metadaten. Sie umfasst ausschließlich Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren und nicht die gesamte Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen.

3. Beschreibung der Daten
   - Die Daten stammen aus dem „Deutschen Gesundheits- und Untersuchungssurvey für Kinder und Jugendliche“ (KiGGS). KiGGS ist Teil des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Instituts (RKI) und umfasst wiederholte Erhebungen zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen. Die Studie liefert bundesweit repräsentative Daten für die Bevölkerung unter 18 Jahren.

Die erste KiGGS-Basiserhebung fand von 2003 bis 2006 als kombinierte Interview- und Untersuchungserhebung statt. Die erste Folgeerhebung, KiGGS Welle 1, wurde von 2009 bis 2012 durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte mittels Telefoninterviews. KiGGS Welle 2 fand von September 2014 bis August 2017 statt. Das Studienprogramm umfasste neben Befragungen auch körperliche Untersuchungen, Laboranalysen von Blut- und Urinproben sowie körperliche Tests.

Die Daten der ersten KiGGS-Basiserhebung (2003-2006) basieren auf einer Sonderauswertung. In den Untersuchungsteil der KiGGS Welle 2 (2014-2017) wurden Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren einbezogen. Daher liegen Daten zu Körpergröße und Körpergewicht für die Altersgruppe unter 5 Jahren ausschließlich für 3- und 4-jährige Kinder vor (n=215 Mädchen und n=221 Jungen).

4. Link zur Datenquelle
   - Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS): KiGGS Welle 2: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/Ausgaben/2018/JoHM_Inhalt_18_01.html?nn=16780210

5. Metadaten zur Datenquelle
   - Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS): https://www.rki.de/DE/Themen/Nichtuebertragbare-Krankheiten/Studien-und-Surveillance/Studien/KiGGS/kiggs_start_inhalt.html?nn=16780210

6. Aktualität und Periodizität
   - Aktualität: t + 12 Monate
   - Periodizität: Unregelmäßig

7. Berechnungsmethode
   - Maßeinheit: Prozent
   - Berechnung: Nicht zutreffend.